

25 - 01- EXAMEN PHYSIQUE EN UROLOGIE - Pr. Lakmichi

L'examen physique en neurologie. Il faudra savoir que l'examen physique en neurologie, comme tout examen physique d'ailleurs, est une étape primordiale pour l'établissement d'un diagnostic ou l'orientation d'un diagnostic. Il faudrait tout d'abord, comme première étape, mettre le patient en confiance en lui expliquant les différents gestes qu'on va réaliser.

L'examen physique en neurologie commence par l'examen des fosses lombaires. Il faudrait tout d'abord savoir la position de l'examen. C'est que le patient doit être en position assise, torse nu, afin de pouvoir inspecter les deux fosses lombaires en la recherche de cicatrices rappelant une intervention antérieure chirurgicale par voie lombaire, la présence d'une boussure témoignant d'une masse lombaire faisant saillir le niveau des fosses lombaires, voir la peau, est-ce qu'il n'est pas inflammatoire, est-ce qu'il n'y a pas d'orifices fusculeux, c'est-à-dire des petits orifices qui donnent du pu.

Et après l'inspection, vient la phase de la palpation. Le patient doit être en décubitus dorsal, les jambes fléchies, les bras tendus le long du corps. Et il faudrait savoir que, chez le sujet normal, le palpé bimanuel ne permet pas habituellement de percevoir le rein, sauf si le sujet est très maigre ou si le rein est ptosé.

Si c'est le sujet normal, les reins ne sont pas palpables. Une masse lombaire devient palpable et doit faire évoquer en particulier un gros rein si elle donne le contact lombaire, c'est-à-dire que la masse de contact de la paroi postérieure, la masse est bien perçue par la main lombaire. Et on cherchera l'existence d'un palatement rénal, c'est-à-dire les impulsions données par la main antérieure et qui sont transmises à la main postérieure.

Cette masse doit être barrée en avant par la sonorité colique. Le schéma montrant la position des mains de l'examineur, une main postérieure au contact de la fosse lombaire et une main antérieure au niveau de l'hypocambre. Cette main antérieure exerce manœuvre de pression au niveau de l'hypocambre afin de pousser la masse au niveau de la main postérieure afin d'avoir un contact lombaire.

Ce schéma montre le balotement rénal, c'est-à-dire les reins qui balotent avec pression de la main antérieure et de la main postérieure alternativement. Et la recherche à la percussion du sonorité colique qui est un signe qui n'est pas toujours présent. Les idéologies ou les causes des gros reins, on trouve tout d'abord l'hydronéphrose qui est une dilatation rénale en amont d'un obstacle et par conséquent il y a une dilatation des cavités phylloclicielles augmentant le volume des reins.

Par la suite, les tumeurs rénales, les piles polycystoses rénales, c'est-à-dire les distances de multitude des kystes dans chaque rein, les kystes rhénaux simples peuvent être de grands volumes et chez l'enfant, les masses, l'embert, c'est essentiellement les néphroblastomes.

L'étape suivante, c'est l'examen du lipogastre. Il se fait pratiquement après mixtion.

Il faudra savoir qu'après la mixtion, la vessie n'est ni palpable ni percutable. En cas de rétention aiguë d'urine, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein vésical que le patient n'arrive pas à l'évacuer, on parle de rétention aiguë d'urine, on est présente d'une masse suspulbienne, en rapport bien entendu avec la vessie qui est trop pleine. Cette masse, elle est arrondie, convexité supérieure, pôle inférieur qui plonge dans la cavité pelvienne.

C'est une masse qui est mate à la percussion, rémittante et sensible à l'examen. La photo à gauche montre un globe vésical, c'est-à-dire une vessie trop pleine. Vous voyez la saillie de la vessie au niveau de l'hypogastre.

Et à droite, les mains de l'examineur à plat afin d'examiner la vessie qui doit être faite avec douceur et prudence parce que la vessie est très douloureuse en présence d'une rétention aiguë d'urine. Les touches épelvières chez l'homme, tout d'abord le toucher recta il permet de percevoir la prostate faisant peu saillie au niveau de la paroi antérieure du rectum. C'est une prostate qui est bien limitée, ferme, composée de deux lobes latéraux séparés par un sillon médian.

Et la prostate, elle est augmentée de volume en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, la surface prostatique quand on touche par le toucher recta, par le doigt, la surface est régulière, lisse, de consistance ferme avec le plus souvent la présence d'un saillis, d'un sillon médian séparant les deux saillis et lobes latéraux. La deuxième situation où la prostate est augmentée de volume c'est en présence d'un cancer de la prostate mais cette fois-ci l'hypertrophie prostatique est irrégulière et la consistance particulière qui est très dure en parle parfois de dureté pierreuse.

La prostatite, dernière situation où la prostate augmente de volume, c'est une infection prostatique donc c'est une prostate qui est inflammatoire, très douloureuse, il faut éviter les massages prostatiques par le toucher recta en présence d'une prostatite parce que c'est une prostate qui est très douloureuse. Le toucher recta, il apprécie comme on a dit la prostate mais non seulement la prostate, il pervient aussi à la base de la vessie si le volume prostatique le permet et les vésicules séminales bien entendu sont pathologiques, c'est-à-dire augmenter de volume si les vésicules séminales sont normales et ne sont jamais pathologiques. Le toucher pévien chez la femme toucher vaginal en premier lieu il permet d'apprécier l'urètre comme vous savez anatomiquement qu'il passe c'est un rapport anatomique au niveau de la façon antérieure du vagin il permet de toucher la base de la vessie et non seulement la base de la vessie mais il permet aussi de toucher l'appareil génital interne à savoir le col utérin et apprécier les annexes et c'est un toucher qui est le plus souvent combiné au palpé abdominal afin d'optimiser les résultats du toucher pévien Examen des organes génitaux externes chez l'homme, en premier lieu la verge on examine le gland qui doit être décaloté s'il n'y a pas eu de ces incisions on recherche la situation du méa et sa taille bien entendu le méa urétral doit être situé anatomiquement au sommet du gland on évalue la taille ou le diamètre du méa urétral peut être

en présence d'un rétrécissement du méa on cherche un écoulement urétral purulent qui oriente vers une urétrite et on cherche aussi des anomalies de consistance du corps cavernier chez les patients non circoncis essentiellement les enfants on peut tomber sur une pathologie qu'on appelle le phimosis qui est un rétrécissement très serré du sommet du prépuce l'examen des organes génitaux externes chez l'homme toujours l'examen du scrotum et de son contenu on apprécie par l'inspection son aspect le glissement est normal la peau scrotale est-ce qu'elle est luisante, est-ce qu'elle est étirée tendue par la palpation on apprécie l'épaisseur de l'apparence scrotale et la mobilité du scrotum et des enveloppes scrotales on cherche aussi l'adhérence mutanée des cécules est-ce que le tissu est mobile par rapport aux enveloppes scrotales s'il est adhérent, s'il n'est pas vraiment mobile par rapport aux enveloppes scrotales ça nous oriente vers une pathologie infectieuse avancée une orthopédimie avancée avec une adhérence des différents enveloppes scrotales on cherche aussi la présence d'une fistule scrotale c'est un orifice dans le tissu des liquides urinants par la palpation aussi on apprécie les tescicules, leur siège leur taille, leur régularité la sensibilité des tescicules et on examine enfin les épидидymes les épидидymes pardon de la tête à la queue en recherchant des nodules ou des noyaux qui sont souvent en rapport avec un kystépидымère on finira l'examen des organes génitaux extérieurs par l'examen des cordons spermatiques en cherchant leur volume et leur consistance le déférent qui est perçu par la palpation sous forme d'un fil de verre on évalue son diamètre et sa régularité on cherche la présence d'une finiculite c'est à dire l'inflammation du cordon spermatique et on cherche surtout une varicocelle qui est une dilatation des veines spermatiques et c'est une dilatation importante on parle d'une dilatation varicose des veines spermatiques l'examen des organes génitaux externes, le scrotum, les tescicules et l'annexe se fait toujours en bimanuel comme vous voyez sur les deux schémas une main qui fixe les tescicules et l'autre main qui examine l'épididyme et vice versa on cherche les anomalies de position tesciculaire d'abord la cryptorchidie crypto c'est un préfixe latin qui signifie cachée en effet le tescicule peut s'arrêter dans son trajet migratoire embryophétale dans un point quelconque sur ce trajet de la fosse lombaire jusqu'à la région inguinale devant un patient qui a une bourse vide on cherche le tescicule au niveau de la région inguinale superficielle puis la région inguinale profonde et s'il n'est pas palpable il est très probablement, s'il n'est pas agénésique il est très probablement en intra-abdominal auquel cas on ne peut pas le palper la deuxième situation c'est que le tescicule est ectopique ectopique se situe par conséquent en dehors de son trajet migratoire soit au niveau de la face interne de la cuisse soit au niveau de la région inguinale en dehors de son trajet migratoire bien entendu mais ce sont des situations très exceptionnelles le plus souvent c'est une cryptorchidie l'examen des organes génitaux externes chez la femme on évalue l'aspect des grandes et petites lèvres la présence de l'eau corée c'est à dire l'issue de sécrétions brûlantes vaginales à travers la bulbe on cherche la présence de métrorragie soit en objectivant du sang issu par la cavité vaginale soit par l'anamnèse et enfin l'aspect du méa urétrale, son siège par rapport à la rapture vaginale chez les deux sexes on examine les aires ganglionnaires inguinales à la recherche d'une lymphatie inguinale qui peuvent être secondaires soit des pathologies infectieuses ou des pathologies tumorales de la peau scrotale de la gueule, de la verge de

l'extrémité distale de l'urètre féminin il faudrait savoir un élément très important c'est que pathologies testiculaires sont seulement un cancer à multiscie donnent des ganglions de part et d'autre des gros vaisseaux rétropéritoneux du fait du drainage lymphatique du tissu cul qui se fait dans la région rétropéritonelle l'examen de la miction le patient doit réaliser une miction devant l'examineur afin de pouvoir évaluer le jet uriné une miction normale elle évacue rapidement et sans effort ni douleur la totalité des urines physiques à l'opposé, en cas de dysurie le jet urinaire est lent à apparaître faible et non à se tarier on évalue aussi les anomalies du volume urinaire on est en présence d'une polyurie si le débit urinaire dépasse les 3 litres par 24 heures on est en présence d'une oligurie si le débit urinaire est inférieur à 400 ml par 24 heures et on est en présence d'une anurie si la durée est inférieure à 100 ml par 24 heures on évalue aussi l'aspect des urines urines rouges orientant vers une ématurie plus souvent urines troubles orientant vers une pyurie, une infection urinaire manifeste ou bien exceptionnellement des urines lactécentes si la présence de lymphes dans les urines on est en présence d'une chilurie en conclusion l'examen clinique en urologie est une étape fondamentale dans l'établissement des diagnostics appropriés doit être conduit avec parcimonie et application pour ressortir des éléments objectifs et il faudra savoir maîtriser l'examen urologique afin de ne pas passer à côté d'une pathologie grave